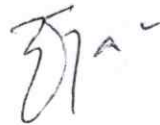


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L2-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	21 November 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	21 November 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO ☒

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Petugas Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15 November 2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15 November 2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 16 November 2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17 November 2022

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 1 dari 6 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 21-11-2022 Tgl.kaji ulang: 21-11-2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam pengambilan darah donor untuk mendapatkan darah yang aman secara konvensional untuk memenuhi kebutuhan transfusi bagi penyembuhan penyakit atau pemeliharaan kesehatan sesuai standar.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas pengambilan darah yang kompeten, melaksanakan kewaspadaan standar di UDD Palang Merah Indonesia dalam melakukan pengambilan darah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai, persiapan dokumentasi, identifikasi pendonor, desinfeksi lengan pendonor, pengambilan darah, perawatan luka tusuk jarum, dan monitoring pendonor pasca penyumbangan darah.

3. Persyaratan Sistem Mutu (CPOB BPOM NOMOR 10 TAHUN 2017)

3.1 Butir 2.20 Higiene Personil (Teknisi) :

Untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, personil mengenakan APD seperti pakaian pelindung bersih yang sesuai untuk tugas yang mereka lakukan. Gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah

3.2 Butir 7.36 s/d 7.50

Pengambilan darah lengkap

Sebelum pengambilan harus konfirmasi identitas donor. Proses pengambilan darah dilakukan dalam sistem tertutup untuk menghindari kontaminasi sehingga didapatkan darah yang aman bagi pasien. Prosedur sudah tervalidasi. Peralatan sudah dikualifikasi dan bahan habis pakai sudah divalidasi. Disinfeksi tangan petugas dan di area titik phlebotomy harus dilakukan dengan menggunakan larutan disinfektan sesuai prosedur. Masa kadaluwarsa larutan disinfektan harus tercatat. Pengambilan sampel yang sudah terlabel hendaklah meminimalkan resiko kontaminasi mikroba. Saat proses pengambilan darah pastikan tercampur dengan antikoagulan dalam kantong darah, catat lama pengambilan di formulir dan label di kantong. Semua proses harus tercatat dan pastikan kecocokan identitas antara kantong, sampel dan formulir pencatatan

3.3 Butir 7.55 s/d 7.64

Keamanan Donor

DOKUMEN KENDALI
Salinan 1

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 2 dari 6 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 21-11-2022 Tgl.kaji ulang: 21-11-2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

Pastikan pasca pengambilan darah, pendonor diberi arahan untuk tidak melakukan hal yang berisiko terhadap pendonor. Monitor keadaan pendonor saat dan pasca proses pengambilan serta saat makan dan minum di ruang istirahat. Bila terjadi reaksi samping terhadap donor pada saat pendonor telah meninggalkan UDD, diberikan petunjuk penanganan selanjutnya. Catat dan evaluasi reaksi pendonor yang terjadi saat dan pasca proses pengambilan.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah
- 4.2 PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat pelindung tubuh yang digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari risiko paparan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, ekskreta.
- 5.2 Anti koagulan adalah zat kimia untuk mencegah terjadinya pembekuan darah dan sebagai pengawet, sehingga darah dapat disimpan dalam waktu tertentu sesuai komponen darahnya. Antikoagulan yang digunakan tergantung pabrik kantong darah, dapat berupa:
 - 5.2.1 ACD/ ACDA : Acid Citrate Dextrose/ Acid Citrate Dextrose Adenine
 - 5.2.2 CPDA : Citrate Phosphate Dextrose Adenine
 - 5.2.3 SAGM : Saline Adenine Glucose Maltose
- 5.3 Sampel darah adalah cairan sel darah merah, plasma/serum pendonor dengan volume masing-masing 3 mL atau sesuai kebutuhan yang ditampung ke dalam tabung sampel dengan atau tanpa antikoagulan untuk uji konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi, uji saring IMLTD metoda ELISA/CLIA, dan NAT tergantung alat yang digunakan.
- 5.4 Waktu Pengambilan adalah durasi atau lamanya proses pengambilan darah dimulai dari jarum ditusukkan, darah mengalir ke kantong sampai darah memenuhi kantong sesuai dengan volume kantong tersebut.
- 5.5 Desinfeksi adalah cairan pembersih lengan pendonor untuk menghilangkan bakteri dan kotoran dengan menggunakan alkohol 70% dan povidone iodine
- 5.6 Kejadian yang tak diinginkan saat atau pasca pengambilan darah dapat berupa mual, pusing, pingsan, syok hipovolemik, nyeri, arteri venosa shunt, intoksikasi sitrat

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 3 dari 6 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 21-11-2022 Tgl.kaji ulang: 21-11-2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer kualitas	- Melakukan Kontrol Dokumen Pengambilan Darah - Mengesahkan, meninjau ulang dan memastikan SPO dan formulir terkait
Kepala Bidang Pelayanan Darah	- Melakukan perencanaan kegiatan pengambilan darah - Memberikan persetujuan pada SPO dan keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sub bidang penyediaan darah - Menindaklanjuti laporan reaksi samping
Kepala sub bidang/ seksi Penyediaan Darah	- Mengatur kecukupan petugas, peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan - Membuat revisi SPO - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya - Melaporkan reaksi samping
Dokter	Bertanggungjawab jika terjadi reaksi saat dan pasca proses pengambilan darah berlangsung
Petugas Teknis Pengambilan Darah (TTD/ATD/Perawat)	- Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan - Melakukan proses pengambilan darah donor sesuai SPO - Melakukan pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikannya
Petugas Administrasi	- Bertanggung jawab menginput data donor ke SIM UDD - dan membuat kartu donor
Petugas Konsumsi Donor	Menyiapkan dan membagikan menu donor

DOKUMEN TERKENDAL
No:

7. Prosedur

- 7.1 Pendonor dipersilahkan untuk mencuci dan mengeringkan kedua lengan. Jika tidak tersedia fasilitas cuci lengan boleh menggunakan tissue *antiseptic*, lihat IK Cuci Lengan Donor no UDDP-PDD-L3-005
- 7.2 Pendonor dipersilahkan duduk di kursi donor
- 7.3 Lakukan konfirmasi ulang data donor di samping kursi donor dengan menanyakan nama, tanggal lahir dan golongan darah dengan pertanyaan aktif

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 4 dari 6 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 21-11-2022 Tgl.kaji ulang: 21-11-2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

- 7.4 Petugas membuka kemasan kantong darah, beri tanggal pertama buka
- 7.5 Tempelkan label *barcode* pada formulir, kantong darah, kantong satelit, dan tabung sampel yang telah tervalidasi, serta musnahkan bila ada label *barcode* yang tersisa dengan cara disobek disamping kursi donor dan catat jumlah sisa *barcode*, lihat IK Persiapan Kantong Darah No. UDDP-PDD-L3-006
- 7.6 Lakukan persiapan area lengan donor yang akan ditusuk dengan mencari akses vena memperhatikan kesehatan serta kebersihan lengan donor. lihat IK Pengambilan darah No. UDDP-PDD-L3-007
- 7.7 Lakukan proses pengambilan darah dan sampel darah serta perawatan luka sesuai Instruksi Kerja Pengambilan Darah No. UDDP-PDD-L3-007
- 7.8 Perhatikan durasi pengambilan untuk pembuatan komponen selanjutnya. Jika kurang dari 12 menit dapat diolah menjadi semua komponen darah yang dapat ditransfusikan, jika waktu pengambilan selama 12 – 15 menit dapat diolah hanya menjadi PRC, apabila lebih dari 15 menit darah tidak dapat digunakan.
- 7.9 Lakukan penanganan pada pendonor yang mengalami reaksi yang tidak diinginkan, lihat IK Penanganan reaksi donor akibat pengambilan darah donor No. UDDP-PDD-L3-013
- 7.10 Lakukan penanganan pada pendonor yang mengalami gagal saat proses pengambilan darah, lihat IK pengambilan darah donor yang gagal No. UDDP-PDD-L3-014
- 7.11 Lakukan pengamatan pada pendonor saat menikmati menu donor sekitar 15 menit, jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan selama masa pengamatan lihat IK Penanganan reaksi donor akibat pengambilan darah donor No. UDDP-PDD-L3-013

8. Dokumen Terkait

- 8.1 IK No. UDDP-PDD-L3-005 Cuci Lengan Donor
- 8.2 IK No. UDDP-PDD-L3-006 Persiapan Kantong Darah
- 8.3 IK No. UDDP-PDD-L3-007 Pengambilan Darah
- 8.4 IK No. UDDP-PDD-L3-013 Penanganan Reaksi Donor akibat Pengambilan Darah Donor
- 8.5 IK No. UDDP-PDD-L3-014 Pengambilan Darah Donor yang Gagal

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Formulir Barcode Donor



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL		Halaman 5 dari 6 Nomor : UDDP-PDD-L2- 003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 21-11-2022 Tgl.kaji ulang: 21-11-2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

10. Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal Efektif	Referensi	RiwayatPerubahan
001	21/11/2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

